

Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental

Paulo Heraldo Costa do Valle

Aula 02

Medicina como
Eficiência Global



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
ANALICE OLIVEIRA FRAGOSO

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

Autor

PAULO HERALDO COSTA DO VALLE

Olá. Meu nome é Paulo Heraldo Costa do Valle. Sou formado em fisioterapia, com mestrado e doutorado em fisiologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com uma experiência técnico, profissional e acadêmica na área de saúde a mais de 25 anos. Trabalhei em várias como a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), Universidade Gama Filho (UGF), Universidade Ibirapuera (UNIB), Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e Kroton Educacional. Já trabalhei como consultor AD HOC do MEC para autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação durante 10 anos e fui membro da Comissão Assessora do Curso de Fisioterapia do Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE.

- Fui membro da Comissão de Qualificação de Cursos e da Comissão de Educação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO e membro da Comissão de Sindicância do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO.
- Fui Vice Presidente da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia e Presidente da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia.
- Além da Telesapiens já produzi conteúdos para a Kroton Educacional, Editora Guanabara Koogan, 5G Educacional, Uninter, Delínea, Must e Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.

Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso trabalho junto com a Editora Telesapiens compondo o seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo sempre.

Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Conceito saúde-doença	10
Períodos da história	10
Organização Mundial da Saúde	11
Evidências nos fósseis	11
Relação causalidade na antiguidade.....	13
Medicina grega.....	14
Importância de Hipócrates	15
A medicina como ciência global.....	18
Cada doença possui uma causa	19
Cadeia e Redes de Causalidade.....	21
História natural da doença	23
Introdução.....	23
Pré-patogênico.....	23
Patogênese.....	24
Triade ecológica.....	24
Fatores causais.....	25
História natural das doenças e níveis de prevenção..	26

Promoção da saúde	26
Proteção específica.....	26
Relatório Lalonde	28
Crítica ao positivismo e etiologia social no processo saúde- doença	29
O homem como ser biológico e social.....	30

UNIDADE

02

MEDICINA COMO EFICIÊNCIA GLOBAL

INTRODUÇÃO

Olá tudo bem com você! Gostaria de convidar você momento para continuarmos esse processo de conhecimento e aprendizagem. Tenho certeza que será muito enriquecedor, repleto de desafios e estímulos para o seu o crescimento.

Você é o nosso convidado especial para continuar essa viagem por meio do conhecimento, durante essa trajetória você irá se deparar com trilhas muito interessantes e desafiadoras em todo esse percurso.

Podemos continuar?

O tema desta segunda unidade é a história da saúde e doença, o qual está dividido nos seguintes conteúdos:

- Conceito saúde-doença.
- A medicina como ciência global.
- História natural da doença.
- Relatório Lalonde.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2 – Medicina como eficiência global. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

- Estudar em detalhes o conceito saúde-doença;
- Estudar em detalhes a medicina como ciência global;
- Estudar em detalhes a história natural da doença;
- Estudar em detalhes o Relatório Lalonde.

Vamos, então, rumo ao conhecimento. Bons estudos!

Conceito saúde-doença

Períodos da história

Em cada período da história pode ser observado diferentes conceitos sobre saúde e doença, uma vez que existem várias interpretações, sendo que a saúde já chegou a ser considerada como uma forma de silêncio orgânico, significando do ponto de vista fisiológico um estado de harmonia e equilíbrio emocional onde todos os sistemas estavam em funcionamento de forma normal e ordenada. Essa consideração acabava deixando de lado tanto as questões mentais como sociais (REIS, 2016).

O conceito de saúde pode ser encontrado como "estado do indivíduo onde as funções orgânicas, físicas e mentais estão dentro da normalidade".

Agora eu pergunto, o que pode ser considerado como uma situação normal ou uma boa saúde?

Esta normalidade pode estar relacionada, por exemplo, com a altura do indivíduo?

A partir de qual altura então o indivíduo pode ser considerado como normal?

Portanto a grande pergunta realmente é:

Existe uma linha que separa o que é a normalidade da anormalidade?

Sem dúvida alguma existe uma linha muito tênue separando o que é normal do que não normal, ou separando a saúde da doença, portanto não podemos pensar que saúde é apenas a ausência de doença, a saúde compreende muito mais coisas do que apenas a ausência de doenças.

O indivíduo com a sua saúde plena encontra-se em equilíbrio físico, mental e espiritual.

Organização Mundial da Saúde



DEFINIÇÃO:

Já a Organização Mundial de Saúde conceituou a saúde como: "Estado completo de bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças".

Neste conceito já pode ser observado a inclusão das dimensões mental e social, porém, pensando na aplicação prática, fica um pouco vago, uma vez que não está claro o que é um completo estado de bem estar.

Portanto como podemos fazer esta avaliação?

Vamos ver em detalhes todo este processo na sequência do conteúdo.



VOCÊ SABIA?

A saúde e a doença podem ser consideradas como dois estados onde o indivíduo acaba flutuando ao longo de toda a sua vida, sendo duas condições ligadas fortemente.

Evidências nos fósseis

Existem fortes evidências nos fósseis encontrados a milhões de anos que comprovam que as doenças sempre existiram (REIS, 2016).

O doente daquela época precisava se esconder para não ser agredido por indivíduos que queriam a sua pele ou as suas armas, muitas vezes ele acabava lambendo as suas feridas esperando que as mesmas fossem curadas, um comportamento igual a dos animais em geral (BRINQUES, 2015).

Existem desenhos bastante antigos nas cavernas onde se pode observar os indivíduos cobertos com peles e máscaras dançando de forma muito semelhante como os feiticeiros atuais da África.

Naquela época a função desses indivíduos era espantar os maus espíritos e curar todas as doenças e garantir uma ótima caça, porém naquela época não existia a preocupação dos indivíduos em sepultar os cadáveres (FRANCO, 2011).

Figura 1: Homem primitivo



Fonte: (cc)Happy Midnight / Wikimedia Commons

VOCÊ SABIA?



A associação das duas funções que são o cuidado ou reparo da saúde e a provisão dos alimentos, mostra a primeira interpretação da doença, relacionada com a introdução dos maus espíritos no corpo, uma concepção que ainda hoje é importante e presente para algumas camadas da população.

Relação causalidade na antiguidade

Figura 2: Grécia antiga



Fonte: ©Raphael (1843-1520) / Wikimedia Commons

As primeiras observações com relação a causalidade na antiguidade são divididas em duas vertentes:

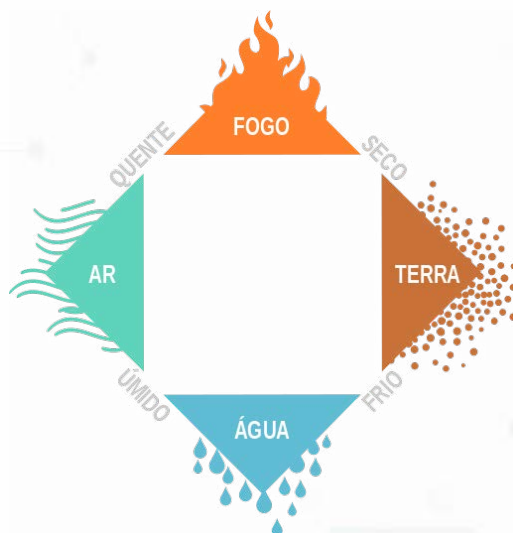
- Considerava o corpo como um reservatório de causas externas que poderiam ser natural ou sobrenatural. Essa concepção estava presente nos povos assírios, caldeus, egípcios e hebreus.
- Considerava a doença como um desequilíbrio entre os elementos que constituem o corpo humano, devido uma alteração no ambiente físico. Essa concepção estava ligada à medicina hindu e aos chineses.

O homem tinha um papel muito ativo em todo o processo e, as causas eram naturais (FRANCO, 2011).

A primeira vertente é chamada de ontológica localizante "A doença entra e sai do homem como por uma porta", enquanto a segunda é chamada de dinâmica e totalizante (REIS, 2016).

Medicina grega

Figura 3: Quatro elementos do corpo



Fonte: ©Dianakc / Wikimedia Commons



IMPORTANTE:

A medicina grega era baseada também na concepção de equilíbrio, para Platão o corpo era composto pelos quatro elementos: Terra, Fogo, Água e Ar.

Sendo que vários fatores poderiam ser as causas que iriam produzir os distúrbios ou as moléstias, por exemplo:

- Abundância de um desses elementos ou a falta deles.
- Mudança de lugar fazendo com que saia da posição natural para outra que não estão tão adaptados.
- Um deles é forçado a receber a quantidade que não é própria para ele, mas apropriado para outra espécie (REIS, 2016).

Importância de Hipócrates

Figura 4: Retrato de Hipócrates



Fonte: ©Morgado de Setúbal (1752-1809) / Wikimedia Commons

Posteriormente Hipócrates fez uma correspondência entre os humores, elementos, qualidades e órgãos sede, através da observação da natureza e da prática clínica (BRINQUES, 2015).

IMPORTANTE:



Em sua obra do Dos ares, das águas e dos lugares, Hipócrates observou que deve ser considerado os efeitos que cada estação do ano pode produzir, uma vez que nem todas são iguais, diferindo muito entre elas.

Devendo ser considerado, por exemplo, os ventos quentes e frios, principalmente os que não são universais, devendo ser apresentado principalmente os que são particulares a cada uma determinada região (FRANCO, 2011).

Também deve ser levado em conta as propriedades da água uma vez que as mesmas podem ser diferenciadas em gosto e som, de forma que a propriedade de uma, acaba diferenciando muito da outra (BRINQUES, 2015).

VOCÊ SABIA?



Por meio desses ensinamentos devemos ficar atentos aos problemas que podem surgir, por exemplo, ao chegarmos em um cidade não devemos ignorar as doenças locais ou ainda a natureza das que são dominantes. (BRINQUES, 2015).

Essa forma de observar a questão quanto a causalidade foi predominante durante todo o feudalismo, não apresentando praticamente nenhuma mudança durante todo este período.

Já durante a Idade Média houve várias epidemias de pestes. Nesse período boa parte da população considerava essas doenças como punição de Deus (REIS, 2016).

Não foram só os judeus (que eram considerados como os culpados pela existência de todas as doenças e pestes) que sofreram nessa época, mas também os leprosos sofriam porque que eram

considerados como os culpados pela poluição dos poços e todos os outros locais.

Ao final do período feudal em função de muitas epidemias que estavam aumentando por toda a Europa voltou a ser discutida a causalidade (FRANCO, 2011).

Desde o Renascimento a medicina voltou a ser praticada pelos leigos e nesse momento os experimentos científicos voltaram a ser praticados (BRINQUES, 2015).

Para tentar explicar a progressão das doenças, cogitou-se a possibilidade de a causa ser a existência de partículas invisíveis as responsáveis pela produção das doenças que acometiam os indivíduos de várias maneiras (FRANCO, 2011).

Por meio dessas concepções surgiu a teoria dos miasmas, que foi proposta por Thomas Sydenham e Giovanni Maria Lancisi, os quais consideravam que todas as doenças tinham origem nos miasmas que eram constituídos por um conjunto de odores fétidos originados de matéria orgânica em putrefação, encontrados nos solos e nos lençóis freáticos contaminados.

Essa teoria se tornou hegemônica até quando apareceu a bacteriologia por volta da metade do século XIX. Durante todo esse período a teoria dos miasmas foi a única forma para interpretar o processo saúde-doença. Atualmente ela é considerada como ultrapassada em detrimento de teorias mais modernas.

No final do século XVIII posteriormente à Revolução Francesa surgiu com bastante força, devido os movimentos revolucionários, a concepção da causalidade social das doenças (REIS, 2016).

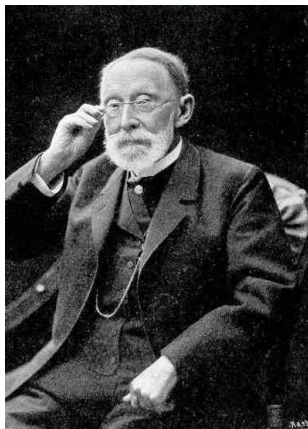
VOCÊ SABIA?



O pensamento com relação às concepções de saúde e doença são determinados historicamente e socialmente, refletindo em todos os casos, as condições e as contraindicações presentes na sociedade. (BRINQUES, 2015).

A medicina como ciência global

Figura 5: Rudolf Ludwig Karl Virchow



Fonte: ©C. Pietzer / Wikimedia Commons

Por meio de uma carta escrita em 1848 o médico Rudolf Ludwig Karl Virchow envolvido também na política, afirmou a sua decepção com os indivíduos, mas não com a época e, declarou que agora não era mais um homem parcial e sim, um homem completo uma vez que tinha conseguido unir a sua crença política e social.

Para ele a medicina era a ciência social e a política seria a medicina em grande escala, outros médicos alemães se uniram a ele para lutar pelas reformas médicas (REIS, 2016).

Eles acreditavam que a ciência médica era intrínseca e essencialmente social e enquanto não houvesse o reconhecimento na prática, não teria como ser usufruído os seus benefícios.

IMPORTANTE:

Esse grupo de médicos apresentava princípios estabelecidos, como a saúde do povo sendo um objeto de evidente de responsabilidade social e dever da sociedade e do Estado.



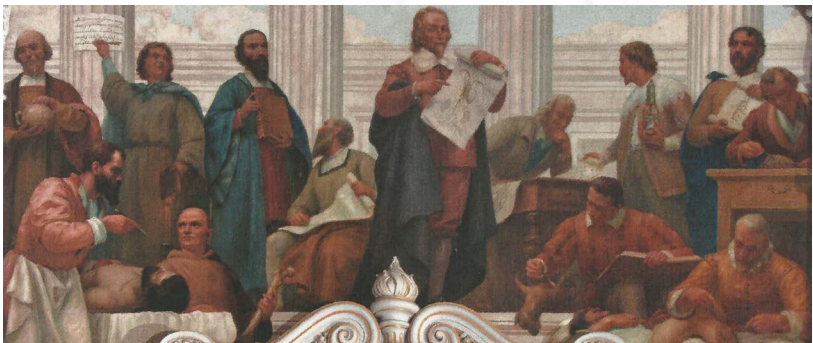
Para eles uma condição primordial, era a proteção do povo com relação aos perigos, o salvamento das vidas e a saúde de todos os cidadãos. As condições econômicas e sociais possuíam um efeito muito importante com relação a saúde e a doença.

Essas relações precisaram ser submetidas a uma pesquisa científica, eles acreditavam que a pobreza, fome e a miséria não eram iguais a morte, e que a doença e o sofrimento crônico eram conspirados como companheiros inseparáveis, onde o preconceito, a ignorância e a estupidez eram grandes fontes para o seu aparecimento.

Outro princípio estava relacionado com as providências com relação a promoção da saúde e o combate a doença e que, as medidas escolhidas deveriam ser tanto sociais como médicas (REIS, 2016).

Cada doença possui uma causa

Figura 6: Medicina do Renascimento



O Renascimento foi considerado como um importante período com muitas transformações, como, por exemplo:

- Econômicas;
- Políticas;
- Culturais;
- Científicas.

Nesse período a humanidade já estava livre do regime feudal e era estimulada quanto ao grande desenvolvimento do capitalismo, porém, o todo era sempre submetido a análise e o desdobramento de todas as partes com o objetivo de aprofundar o conhecimento (REIS, 2016).

O século XVIII foi marcado pelo estudo do corpo humano. Nessa época foi apresentado grande desenvolvimento tanto na anatomia como também quanto ao conhecimento das alterações anatômicas em função das doenças (FRANCO, 2011).

Nesse período foi necessário sair do conhecimento geral que era superficial para um conhecimento das partes, como um pré-requisito necessário para o entendimento do funcionamento do todo, ou seja, o conhecimento passou então de uma fase de contemplação da filosofia para a experimentação, da análise, mesmo com bases mais antigas (BRINQUES, 2015).

Foi lançado nesse período todas as bases com relação ao método científico hegemônico da atualidade sendo a base material para a superação da teoria dos miasmas, que foi substituída pela evolução da bacteriologia em meados do século XIX.

Por meio do desenvolvimento da bacteriologia, tanto a teoria dos miasmas como a discussão quanto a causalidade social das doenças foram finalizadas e substituídas por uma causa externa, que era visível, podia ser identificada e foi denominada primeiramente de bactéria, depois de parasita e posteriormente de vírus.

Foi então iniciado o período com a predominância da concepção unicausal, ou seja, para cada doença existe um agente etiológico que pode ser combatido através de produtos químicos ou vacinas (REIS, 2016).

Essa concepção foi aplicada para o estudo das doenças infecciosas e foi mantida assim até os primeiros anos do século XX, fase onde foram iniciados os projetos de grande escala com o objetivo de atingir a erradicação das doenças tropicais nos territórios ou países que eram explorados pelas grandes companhias, porém, eram limitados para dar conta quanto à discussão da causalidade. Posteriormente foram substituídos por teorias consideradas como mais abrangentes.

Cadeia e Redes de Causalidade

Brian MacMahon representou uma importante corrente de pensamento epidemiológico que teve grande influência no desenvolvimento contemporâneo da epidemiologia. Junto com outros professores da Universidade de Harvard sistematizou as suas ideias quanto a causalidade (FRANCO, 2011).

Para MacMahon o objetivo da epidemiologia é descobrir as relações que possibilitam algum tipo de intervenção para a prevenção das doenças, definindo a associação da causa com aquela existente entre duas categorias de eventos, onde era observado uma mudança quanto a frequência ou na qualidade de um seguido da alteração do outro (BRINQUES, 2015).

Discutindo então o problema das relações quanto aos eventos que podem ser associados ou independentes, ou seja, nenhuma associação estatística encontrada entre eles.

A associação estatística é considerada como uma condição necessária para que exista uma associação causal, sendo que a sua existência não significa obrigatoriamente a causalidade (BRINQUES, 2015).

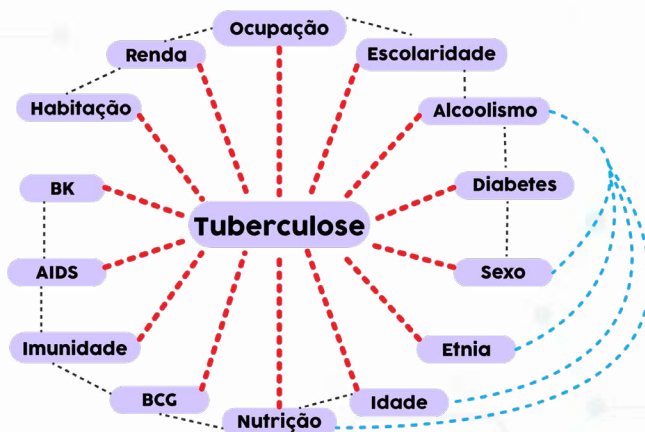
A menor quantidade das associações é causal, sendo a maioria secundária. A causa pode ser expressa apenas em termos estatísticos, podendo somente ser realizado para categoria de eventos e não para eventos isolados, pois, não existe um sentido para a aplicação estatística de apenas um caso, mas sim, com relação a um grupo pode-se sugerir a associação causal e não um caso individual.

Ele considera a cadeia de causalidade como uma simplificação e que na realidade deve ser considerada toda a genealogia mais propriamente como uma rede onde a sua complexidade e origem acabam ficando além da compreensão (REIS, 2016).

O papel da epidemiologia é, por meio dos estudos científicos, reconstruir a rede de causalidade que é encontrada no mundo real. (BRINQUES, 2015).

Na figura a seguir pode ser observado cada um dos fatores apontados de forma direta associado a tuberculose onde essa relação pode ser comprovada estatisticamente.

Figura 7: Exemplo de rede de causalidade para a tuberculose



Fonte: Editorial Telesapiens

MacMahon considera a cadeia da causalidade como uma simplificação, mas na realidade deve considerar toda a genealogia mais propriamente como uma rede onde a complexidade e origem estão além da compreensão (FRANCO, 2011).

Devendo ser destacado a sua posição que coloca de forma explícita em segundo plano a investigação das origens, dando prioridade quanto à descoberta das associações estatísticas que possibilitam uma intervenção, sendo, portanto, o papel da epidemiologia por meio dos

estudos científicos a reconstrução na teoria a rede causalidade sendo observada no mundo real (BRINQUES, 2015).

Verificadas associações entre eles ou ainda como outros fatores antecedentes, possibilita-se construir uma rede de associações muito complexa, nesse exemplo da figura existe apenas algumas associações que foram apresentadas.

A identificação das associações possibilita compreender de forma parcial a questão da causalidade e, a priorização das relações que podem sofrer uma intervenção, tendo como objetivo a promoção da saúde, evitar as doenças ou as complicações e estabelecer os planos de tratamento (FRANCO, 2011).

História natural da doença

Introdução

No ano de 1976 Leavell e Clark propuseram um modelo que foi traduzido como medicina preventiva. Esse modelo teve grande disseminação internacional que até os dias atuais é utilizado como referência para os trabalhos científicos e organização dos programas de saúde.

Eles propuseram uma teoria voltada para a intervenção no âmbito da medicina preventiva estando associada a um conceito da história natural da doença (BRINQUES, 2015).

Para eles a história natural que qualquer processo mórbido no homem, poderia ser dividido em dois períodos:

- Pré patogênico;
- Patogênico.

Pré-patogênico

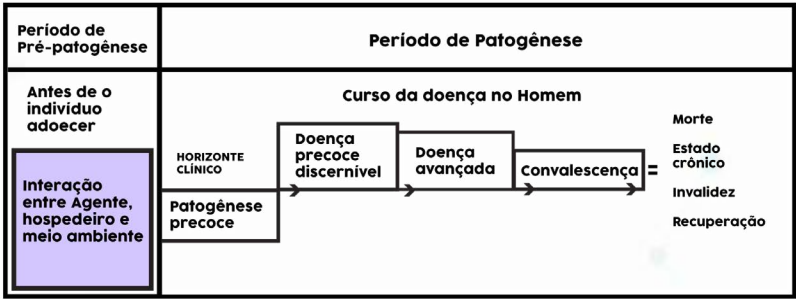
No pré-patogênico existe uma interação preliminar dos fatores que são potencialmente causadores da doença, ainda não está iniciado a interação do hospedeiro, portanto, a história natural ainda está em fase de gestação (FRANCO, 2011).

Patogênese

No momento que os fatores causais vão entrar em contato direto com o indivíduo, é iniciado o período patogênico, sendo observadas alterações fisiopatológicas que são manifestadas posteriormente por meio de sinais e sintomas.

- O período de patogênese é subdividido em:
- Patogênese precoce, antes que iniciam os primeiros sinais e sintomas;
 - Períodos da doença precoce;
 - Doença avançada;
 - Convalescença.

Figura 8: História natural dos processos mórbidos do homem



Fonte: Editorial Telesapiens

A história natural das doenças tem início com a interação dos fatores que são causadores da doença, passando por todo o curso da doença no organismo humano e terminando com a recuperação, estado crônico, invalidez ou morte (BRINQUES, 2015).

Tríade ecológica

- Os fatores causais podem ser repartidos em três conjuntos que são:
- Relacionamentos com o agente;
 - Relacionamentos com o hospedeiro;
 - Relacionamentos com o meio ambiente.

O estado de saúde-doença é dependente tanto da interação como do equilíbrio entre os conjuntos (REIS, 2016).



IMPORTANTE:

A saúde está relacionada com o estado de homeostase, equilíbrio, sendo a doença considerada como o resultado do desequilíbrio (BRINQUES, 2015).

Fatores causais

Os fatores causais estão distribuídos da seguinte forma:

- Relacionados com os agentes biológicos, nutricionais, químicos, físicos ou mecânicos que por meio da sua presença ou ausência podem iniciar ou perpetuar os processos mórbidos.
- Relacionados com o hospedeiro como idade, sexo, raça, hábitos, estado civil, hereditariedade, fatores ocupacionais entre outros.
- Relacionados com o meio ambiente: ambiente físico (clima, tempo, estação do ano, entre outros), ambiente biológicos (universo de todas as coisas vivas que envolvem o homem e tudo além do próprio homem) e o ambiente social e econômico.

De acordo com vários pesquisadores uma alteração em qualquer desses fatores acaba tendo interferência direta ou indireta quanto ao estado de saúde-doença nos indivíduos e na população (REIS, 2016).

O modelo pode ser considerado como um avanço com relação às concepções anteriores e de forma mais precisa com relação às interpretações multicausais, visto que vai conseguir agrupar os elementos que estão relacionados com a causalidade e utilizar um conceito quanto ao processo histórico sobre a enfermidade, embora mantenha dentro da dimensão biológica evolutiva.

História natural das doenças e níveis de prevenção

Uma das aplicações mais utilizadas no modelo da multicausalidade de Leavell e Clark é a proposta quanto aos níveis de prevenção que estão relacionados com as etapas da história natural das doenças (BRINQUES, 2015).

Em todas as etapas existentes existe um nível de prevenção, quando realizada no período pré patogênico, a prevenção é denominada de primária e pode ser dividida em dois níveis de aplicação:

- Promoção da saúde;
- Proteção específica.

Promoção da saúde

A promoção da saúde não é aplicada a nenhuma doença em particular. Trata-se de um composto de medidas destinadas para melhorar a saúde das populações em geral, como: a educação para a saúde, alimentação, moradia, prática de atividades físicas e atividades de lazer, participação em atividades associativas e exames de saúde periódicos (REIS, 2016).

Proteção específica

A proteção específica chamada normalmente de prevenção está relacionada com medidas que podem ser aplicadas para algumas doenças ou grupo de doenças. É denominada de prevenção primária e tem como objetivo alcançar ótima saúde, como também, combater todos os tipos de agentes patológicos por meio de algumas ações, como:

- Imunização;
- Uso de preservativos;
- Proteção contra riscos ocupacionais;
- Coleta de citologia para prevenção do câncer de colo do útero;
- Tratamento da água;
- Mudanças nos hábitos de vida (alimentação mais saudável e realização de exercícios físicos).

Esses períodos da patogênese podem ser classificados também como prevenção secundária e terciária.

A prevenção secundária está relacionada com:

- Elaboração do diagnóstico imediato;
- Medidas de limitação de incapacidade;
- Tratamento o mais precoce possível, como o objetivo evitar a

prevalência da doença.

A prevenção terciária está relacionada com:

Reabilitação constituída por ações que tem o objetivo de reabilitar o individuo ao mesmo tempo que está buscando diminuir a sua incapacidade (BRINQUES, 2015).

Figura 9: História natural e níveis de prevenção

Período pré-patogénico		Período patogénico			
Interação entre agente, hospedeiro e meio ambiente		Alterações precoces	➤ Primeiros sinais e sintomas	➤ Estágio avançado da doença	➤ Convalescença
Promoção da saúde	Proteção específica	Diagnóstico e tratamento precoces	limitação do dano		Reabilitação
Prevenção primária		Prevenção secundária			Prevenção terciária
Níveis de aplicação de medidas preventivas					

Fonte: Editorial

Essa proposta permitiu uma visão incorporada da saúde para chamar a atenção quanto à necessidade de atuação em todos os níveis, como também com relação ao fato de que a atuação em cada nível vai prevenir os problemas no nível seguinte.

Essa visão é considerada como bastante útil, porém possui limitações com que serão seguidas posteriormente (REIS, 2016).

Relatório Lalonde

Figura 10: Saúde no Canadá



Fonte: ©Freepik

Em fevereiro de 1971 o Departamento Nacional de Saúde e Bem-Estar do Canadá elaborou um planejamento a longo prazo. O material mais importante produzido foi um documento relacionado para uma nova perspectiva de Saúde dos Canadenses, que ficou conhecido como Relatório Lalonde, nome do ministro da saúde no momento em que foi criado e difundido esse documento.

No início não houve uma grande receptividade pelos partidos políticos, porém posteriormente começou a ser aceito e, no ano de 1984 esse documento acabou tornando-se um documento com alcance no mundo inteiro. Considerado como uma das maiores realizações do movimento de saúde pública moderna (REIS, 2016).

Uma das questões centrais desse relatório é a concepção do campo de saúde. De acordo com o documento, a visão tradicional de campo de saúde é que a medicina é uma fonte da qual são desenvolvidas todas as melhorias que estão relacionadas à saúde (BRINQUES, 2015).

Na maioria dos indivíduos o campo de saúde e o sistema de atenção à saúde são considerados como sinônimos, em função disso uma parte dos recursos são direcionados para buscar a melhora da qualidade e acessibilidade.

Esse conceito de campo de saúde que está presente no relatório foi desenvolvido em 1973 e compreende um eixo que pode ser dividido em quatro elementos:

- Biologia Humana;
- Ambiente;
- Estilo de vida e;
- Organização da atenção a saúde.

aporem, a causa de um problema de saúde é ampliada para uma combinação em proporções diferentes dos quatro componentes (BRINQUES, 2015).

Esse relatório apresentou uma grande influência com relação a reorganização do sistema de saúde no Canadá, como também com relação aos surgimentos dos movimentos voltados para a promoção da saúde, como cidades mais saudáveis, utilizado inclusive no Brasil como uma referência conceitual quanto ao Programa de Saúde da Família (FRANCO, 2011).

Crítica ao positivismo e etiologia social no processo saúde-doença

Muito já foi discutido sobre as relações entre a saúde e a sociedade, porém existe uma grande variação com a concepção e a forma de compreensão.

No final dos anos 1960 principalmente nos países da América Latina houve várias interpretações com relação ao processo saúde-doença, que foram bastante influenciadas pelo pensamento de correntes identificadas com os movimentos sociais que aumentavam na época (BRINQUES, 2015).

O homem como ser biológico e social

O ponto de partida para essa discussão está relacionado com a compreensão de que a saúde e a doença são fenômenos que ao mesmo tempo são biológicos e sociais.

O homem é considerado como um ser material que vive na natureza devendo manter um processo constante para que não morra (FRANCO, 2011).

A relação homem natureza apresenta uma unidade dialética onde ambos vão transformado e se condicionam de forma recíproca. A natureza ficando humanizada e o homem conseguindo superar "seu estatuto natural em favor de um ser humano".

Essa relação não é feita por meio de um homem isolado, mas sim, em contato com outros homens por meio das relações sociais concretas e medidas por meio do trabalho. Portanto o homem é definido como um ser ao mesmo tempo biológico e social (REIS, 2016).

Em função dessa luta com a natureza o homem acaba gastando muito o seu tempo com outras coisas, principalmente preocupado com as coisas materiais, quando deveria estar conectado com a sua essência em um íntimo contato com a natureza, por meio de suas relações sociais concretas, ser enquanto materialidade orgânica e, suas capacidades psíquicas (BRINQUES, 2015).

Com o capitalismo o homem acabou sendo separado da terra, a qual era considerada como o seu laboratório natural. Essa quebra da unidade homem/natureza acabou impossibilitando a aquisição dos produtores para conseguir se organizar por si mesmo, com relação à troca metabólica com a natureza (FRANCO, 2011).

Esse rompimento foi acompanhado da dissolução das relações nas quais o trabalhador desponta como o proprietário dos meios de produção (BRINQUES, 2015).

As relações de produção capitalistas acabaram separando o operário dos seus meios de subsistência-natureza e, acabaram dominando a capacidade de trabalho e a consciência do

trabalhador com relação ao acúmulo do capital, o que é considerado como um caráter muito patogênico. (FRANCO, 2011).

Na produção o produtor acaba transformando a natureza em produtos para satisfazer as necessidades humanas. Por meio do trabalho ele vai gastar energia e colocar sua capacidade física e psicológica, o que vai gerar um desgaste, razão pela qual a produção é considerada como responsável pelo consumo do corpo e da mente dos trabalhadores.

A produção dos objetos é considerada como o consumo dos sujeitos, denominado de consumo subjetivo por Marx, onde o próprio produtor se consome e se gasta, para produzir uma riqueza, onde ao mesmo tempo acaba ocorrendo um desgaste, sendo que é por meio do trabalho que o homem vai desenvolver a sua capacidade física e intelectual e, de modo consequente seu domínio com relação à natureza (BRINQUES, 2015).

Portanto a atividade produtiva é considerada ao mesmo tempo consumo e produção do homem.

Por outro lado, o consumo de objetos é por sua vez a produção dos sujeitos, visto que no consumo, os homens se adaptam da natureza transformada, para se reproduzir como sujeitos biológicos e sociais, denominado de produção subjetiva.

A relação entre a produção e o consumo estava voltada para a distribuição e troca, enquanto no capitalismo a sociedade acabou ficando dividida em classes sociais com tipos diferentes de interesses, o que acabou provocando uma distribuição de forma desigual dos produtos para toda a população (REIS, 2016).

Essa distribuição em diferentes classes sociais acabou provocando uma distribuição de forma desigual com relação às condições da reprodução biológica e social, o que acabou provocando também, uma distribuição desigual da saúde/doença para cada classe social.

O estado e processo saúde/doença estão estipulados de uma maneira que o homem acaba entrando em contato com a natureza, por meio das relações de produção e subordinação ao grau de desenvolvimento das forças produtivas.

Outra categoria muito importante é o modo de vida, constituído tanto pelas condições, como também, por meio da maneira como é desenvolvida a vida do trabalhador longe da esfera produtiva (BRINQUES, 2015).

O modo de vida é como se reproduzem as classes, e, as condições são determinadas tanto pela forma como pela quantidade com o que vão se apropriar com relação à riqueza social e o lugar que ocupam na organização social do trabalho.

Para ser estudado o processo saúde doença é necessário incorporar três diferentes aspectos:

- Relações homem natureza que é caracterizada pelo modo de produção específico;
- Esfera de trabalho;
- Reprodução dos grupos sociais.

O processo saúde doença deve ser avaliado como um conjunto de determinações que vão atuar em uma sociedade concreta e vão produzir nos diferente grupos o aparecimento de riscos ou potencialidades características que vão se manifestar na forma de perfis ou padrões de saúde ou enfermidade, cada grupo social vai apresentar em sua condição de vida e em seu correspondente perfil de saúde/doença, uma rede complexa de processos e formas de determinação onde a investigação epidemiológica deve separar e ordenar por meio da análise.

Em um nível mais geral as causas que são determinantes da saúde doença coletiva são consideradas como maneiras como o homem acaba entrando em contato com a natureza, sendo necessário estudar o grau de desenvolvimento das forças produtivas, relações com a produção e a troca como também o componente ideológico da saúde doença que não atua de forma direta, mas por meio dos elos de caráter sociobiológicos ou biológicos, como, por exemplo, nutrição, microrganismos, agentes traumáticos ou ainda as características do hospedeiro (REIS, 2016).

Existe a dimensão individual que é constituída por meio dos processos que vão levar em última instância ao adoecimento ou à morte, ou ainda, garantir a sustentação da normalidade e o desenvolvimento somático e psíquico.

Cada vez que o indivíduo acaba intensificando e desfrutando de um adequado e ao mesmo tempo suficiente bens ou valores da classe, tanto com relação as condições objetivas de existência, como também, com relação às expressões subjetivas de consciência e organização, o mesmo está desenvolvendo o polo de saúde, enquanto que cada vez que for intensificado as forças destrutivas, ocorrer desgastes, privações e deteriorações por meio de condições objetivas, como, também, por meio das expressões de consciências e organização de classes, está sendo desenvolvido o polo da enfermidade e a mortalidade do perfil saúde doença desse grupo social (BRINQUES, 2015).

As ideias dessa corrente são consideradas como muito interessante uma vez que acabam recolocando a questão social, por meio do estabelecimento de uma hierarquia no complexo campo da causalidade (FRANCO, 2011).

RESUMINDO:



Nesta unidade história da saúde e doença nós estudamos quatro assuntos muito importantes que são o conceito saúde-doença e todos os seus significados, posteriormente foi abordado a medicina como uma ciência global, seguido da história natural da doença e todos os seus processos ao longo da história e por último o Relatório Lalonde que é um importante documento sendo considerado um marco histórico com relação ao movimento da saúde pública no mundo.

BIBLIOGRAFIA

BRINQUES, GB. Higiene e Vigilância Sanitária. São Paulo, Editora Pearson, 2015.

FRANCO, LJ. Fundamentos de Epidemiologia. 2ª Edição, Editora Manole, 2011.

PAPINI, S. Vigilância em Saúde Ambiental: Uma nova Área da Ecologia. São Paulo, Editora Atheneu, 2012.

REIS, LGC. Vigilância Sanitária Aplicada. Curitiba, Editora Intersaberes. 2016.